PROTOCOLLO 2

Screening delle red flags nel dolore orofacciale

Escludere condizioni che richiedono un invio medico prima del trattamento

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Prima seduta	Diagnosi differenziale	5 minuti	Prima visita e se cambiano i sintomi

Indicazioni

- ✓ Ogni nuovo paziente con dolore orofacciale
- ✓ Peggioramento improvviso dei sintomi
- ✓ Mancata risposta al trattamento dopo 4 a 6 sedute

Controindicazioni e precauzioni

- ! Calo di peso, febbre o tumefazione non spiegati
- ! Deficit neurologici o parestesie del volto
- ! Trisma progressivo o storia oncologica del distretto testa collo
- ! Dolore che non varia con la funzione mandibolare

Posizionamento

Paziente: seduto, dopo l'anamnesi.

Fisioterapista: con la checklist delle red flags a portata di mano.

Esecuzione passo dopo passo

1



FASE 1

Sintomi sistemici

Febbre, calo di peso, sudorazione notturna, astenia marcata.

2



FASE 2

Segni neurologici

Parestesie, deficit dei nervi cranici, disturbi visivi o della deglutizione.

3



FASE 3

Segni locali

Tumefazioni, linfonodi aumentati, trisma progressivo, malocclusione improvvisa.

4



FASE 4

Decisione

In presenza di red flags sospendi e invia al medico o allo specialista.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Strumento	Checklist red flags del kit
Tempo	5 minuti
Ripetizione	se compaiono nuovi sintomi

Criteri di rivalutazione

DIAGNOSI DC/TMD	LIVELLO DI DOLORE	IMPATTO PSICOSOCIALE
_____	____ / 10	Basso / Alto
asse I	attuale e medio	asse II

Punti chiave

- ✓ Il dolore dei DTM varia con la funzione mandibolare
- ✓ Un dolore costante e non meccanico va approfondito
- ✓ Documenta sempre l'esito dello screening

Errori da evitare

- ! Trattare prima di aver escluso le red flags
- ! Attribuire ogni dolore del volto all'ATM
- ! Non comunicare al paziente il motivo dell'invio

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Monitoraggio dei segnali	Contattare il fisioterapista in caso di febbre, gonfiore o formicolii	per tutta la durata del percorso

! **Nota clinica.** Arterite a cellule giganti, neoplasie e nevralgie possono simulare un DTM: in caso di dubbio l'invio è sempre la scelta più sicura.

Bibliografia essenziale

1. Schiffman E. et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for clinical and research applications. J Oral Facial Pain Headache. 2014;28(1):6–27.
2. Ohrbach R., Dworkin S.F. The evolution of TMD diagnosis: past, present, future. J Dent Res. 2016;95(10):1093–1101.